

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO (CFSS)

Eje V: Neurocognición y Cribado Breve de Quejas • Escala de Despistaje Rápido de 17 Ítems

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Autoevaluación del Funcionamiento Cognitivo (CFSS - 17 ítems).
Nombre Original	Cognitive Functioning Self-assessment Scale (CFSS; derivación abreviada de cribado).
Autores del Protocolo	Adaptación clínica abreviada basada en la metodología de Broadbent y unidades de memoria.
Ámbito de Aplicación	España e Hispanoamérica; ampliamente implementada en atención primaria y geriatría.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Quejas cognitivas subjetivas de atención, memoria y lenguaje cotidiano.
Tipo de Instrumento	Escala de autoinforme rápido de cribado de quejas cognitivas cotidianas.
Composición de Ítems	17 ítems evaluados en escala tipo Likert de 4 opciones (0 a 3; rango 0 a 51 puntos).
Población y Rango	Adultos y adultos mayores (18 a 90 años); quejas cognitivas subjetivas en consulta general.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos de rápida cumplimentación por el propio paciente o informante.
Régimen de Licencia	Acceso libre para la práctica clínica médica, geriátrica y psicológica sin coste.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CRIBADO RÁPIDO DE QUEJAS SUBJETIVAS

La escala **CFSS** de 17 ítems se configuró como una herramienta ultra-breve para la detección precoz de quejas cognitivas en la consulta de cabecera:

- Economía Temporal en Atención Primaria:** Los instrumentos completos de fallos cognitivos (como el CFQ de 25 ítems o el MFE de 30 ítems) resultan a menudo extensos para consultas ambulatorias saturadas; la CFSS condensa los 17 despistes con mayor valor discriminativo.
- Detección de Quejas Subjetivas de Memoria (QSM):** Permite objetivar el grado de preocupación y disfunción cotidiana que experimenta el paciente antes de que se presenten alteraciones francas en pruebas de rendimiento formal (como MMSE o MoCA).
- Puerta de Entrada al Diagnóstico Diferencial:** Ayuda al clínico a determinar si el paciente debe ser tranquilizado por olvidos benignos del envejecimiento o si requiere una derivación a neuropsicología o neurología.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (17 ÍTEMS)

Dimensión Evaluada	Reactivos	Descripción Operativa de los Fallos Cotidianos
1. Memoria Reciente y Cotidiana	Ítems 1, 3, 5, 8, 11, 14, 16 (7 ítems)	Olvido de recados, de dónde se dejaron las llaves u objetos de uso diario, olvidar si se ha realizado una acción automática (cerrar la puerta, apagar la luz).
2. Atención y Concentración	Ítems 2, 6, 9, 12, 15, 17 (6 ítems)	Dificultad para mantener el hilo en conversaciones grupales, perder la concentración al leer libros o prensa y despistes en multitarea.
3. Acceso Léxico y Denominación	Ítems 4, 7, 10, 13 (4 ítems)	Fenómeno de tener la palabra en la punta de la lengua, olvidar nombres de vecinos o conocidos e imprecisión verbal en el habla espontánea.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios clínicos en consultas de adultos y personas mayores ($N > 620$) avalan su utilidad como escala breve de cribado:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.86 - 0.89	Alta cohesión psicométrica en una escala breve de solo 17 ítems.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.81 (intervalo 1 mes)	Buena reproducibilidad de puntuaciones en pacientes clínicos estables.
Validez Concurrente	$r = 0.68$ con MFE; 0.65 CFQ	Fuerte correlación con cuestionarios extensos de quejas cognitivas.
Sensibilidad en QSM	Sensibilidad = 84%	Excelente capacidad para detectar quejas de memoria subjetivamente perturbadoras.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 80%	Discrimina adecuadamente quejas normales asociadas a la edad de perfiles alterados.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Escala de Valoración de Respuestas:** Cada reactivo se califica de 0 a 3 según la frecuencia autopercebida: 0 = Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = A veces, 3 = A menudo.
- **Cálculo de la Puntuación Total:** Sumatoria simple de las respuestas en los 17 reactivos:

$$\text{Puntuación Total CFSS} = \sum_{i=1}^{17} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 51 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación directa, mayor severidad e interferencia subjetiva de las quejas cognitivas. Una puntuación de 0 denota ausencia absoluta de fallos autopercebidos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel Queja	Significación Clínica y Recomendación de Manejo
Preservado Mínimo	0 a 14 puntos	Baja	Funcionamiento cognitivo habitual; quejas esporádicas fisiológicas benignas.
Quejas Leves	15 a 24 puntos	Moderada	Olvidos cotidianos tolerables; aconsejar pautas de estilo de vida saludable.
Quejas Significativas	25 a 34 puntos	Alta (Corte)	Punto de corte de cribado positivo (≥ 25 pts) derivar a valoración formal.
Quejas Severas	≥ 35 puntos	Muy Alta	Elevación acusada descartar síndrome depresivo vs. deterioro cognitivo leve.

PUNTO DE CORTE DISCRIMINANTE PARA CRIBADO CLÍNICO (CFSS ≥ 25 PUNTOS):

Una puntuación ≥ 25 puntos (equivalente a responder en promedio "a veces" o "a menudo" a la mayoría de los fallos cotidianos) constituye el dintel de cribado positivo. Dicha puntuación indica que las dificultades autopercebidas sobrepasan la variabilidad normativa y ameritan la aplicación de un test neuropsicológico objetivo (MoCA o TAVEC) y una escala de depresión (GDS / BDI-II).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE QUEJAS COGNITIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

PROTOCOLO DINÁMICO DE ACTUACIÓN CON EL CFSS (17 ÍTEMS):

- **Paso 1 (Administración Rápida en Consulta de Medicina General / Psicología):** Entregar la escala de 17 ítems al paciente que consulta por “pérdida de memoria o despistes” (tiempo de llenado: 3 minutos).
- **Paso 2 (Estratificación por Puntuación y Vía Diagnóstica):**
 - **CFSS < 25 puntos:** Tranquilizar; explicar el fenómeno del olvido benigno asociado a la edad; no se precisa estudio invasivo.
 - **CFSS ≥ 25 puntos:** Administrar el test de cribado cognitivo de Montreal (**MoCA**) y una escala afectiva (**GDS-15** o **PHQ-9**):
 - Si **MoCA ≥ 26** y **Escala afectiva elevada** → Pseudodemencia depresiva / Ansiedad generalizada; **tratar cuadro anímico**.
 - Si **MoCA < 26** (especialmente con caída en memoria diferida) → **Sospecha de Deterioro Cognitivo Leve (DCL)**; derivar a Neurología.
- **Paso 3 (Reevaluación a los 6 Meses):** Verificar si las quejas remitieron tras la intervención psicosocial o psicoterapéutica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIFERENCIACIÓN DE ANSIEDAD VS. DETERIORO

Identificación: Varón de 54 años, directivo de empresa, consulta en su centro médico sumamente angustiado porque “cree que está desarrollando un Alzheimer prematuro”, tras notar que olvida nombres de clientes, pierde las gafas constantemente y tiene que releer varias veces los informes.

Evaluación Inicial de Cribado con CFSS (17 ítems):

- **Puntuación Total CFSS = 31 / 51 puntos (Quejas cognitivas subjetivas elevadas,** netamente superior al corte de 25).
- **Desglose:** Puntuaciones máximas de 3 (“a menudo”) en ítems de multitarea, concentración en lectura y fenómeno de la punta de la lengua.

Protocolo Diferencial Complementario:

- **MoCA (Evaluación Cognitiva de Montreal): 29 / 30 puntos** (rendimiento óptimo, memoria diferida 5/5, sin daño orgánico).
- **Escala de Ansiedad de Hamilton (HAMA): 26 puntos** (ansiedad psíquica y somática moderada-grave).

Conclusión Diagnóstica: Bloqueo atencional secundario a sobrecarga laboral y trastorno de ansiedad generalizada, sin evidencia de proceso neurodegenerativo.

Intervención: Psicoeducación desmitificando el temor a demencia, reestructuración cognitiva, entrenamiento en técnicas de relajación muscular y ordenación de pausas laborales. A los dos meses, la puntuación CFSS bajó a 12 puntos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISCORDANCIA QUEJA / TEST:

Una CFSS alta con rendimiento neuropsicológico objetivo normal descarta demencia inicial y señala casi con total certeza un origen afectivo/estrés.

RIESGO DE INFRADETECCIÓN:

En demencias francas con anosognosia, el paciente marcará 0 en la CFSS; ante queja de familiares, administrar siempre un test de ejecución directa.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Broadbent, D. E., et al. (1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates. *British Journal of Clinical Psychology*, 21(1), 1-16.
2. Montejo, M., Montenegro, M., Reinoso, A. I., et al. (2012). Estudio de la queja subjetiva de memoria en personas mayores y su relación con el deterioro cognitivo. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 47(4), 161-166.
3. Jessen, F., et al. (2014). A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. *Alzheimer's & Dementia*, 10(6), 844-852.
4. Carrillo-Mora, P., et al. (2013). Quejas cognitivas subjetivas: Enfoque clínico y diagnóstico. *Revista Mexicana de Neurociencia*, 14(6), 335-343.